

COLANGITIS

Latras I, Díez S, Alcoba L, González R, Rodríguez L, Jorquera F, Camino JT

INTRODUCCIÓN

La colangitis se define como una infección sistémica originada en la infección de la vía biliar y en el aumento de la presión intraductal en el árbol biliar.

La forma de entrada más frecuente de la infección es la vía ascendente desde el duodeno, aunque también puede provenir de vía portal, linfática o sistémica desde la arteria hepática. El éstasis biliar es un factor facilitador en una parte importante de los casos.

Las **causas** más habituales son:

- Coledocolitiasis.
- Estenosis biliares benignas: inflamatorias, post infecciosas, anomalías congénitas.
- Tumores biliopancreáticos: colangiocarcinoma, ampuloma, cáncer de páncreas.
- Infecciones por parásitos.
- **Síndrome de Mirizzi:** impactación de un cálculo en el cuello de la vesícula o en el conducto cístico produciendo estenosis del conducto biliar común secundario a compresión directa o cambios inflamatorios provocados por la litiasis.
- **Síndrome de Lemmel:** divertículo en la papila duodenal que desplaza o comprime la entrada del colédoco o del conducto pancreático.
- Manipulaciones de la vía biliar: ocurre en alrededor del 1% de las CPRE.

Es importante realizar un buen diagnóstico diferencial desde el Servicio de Urgencias ya que se trata de un cuadro de elevada mortalidad, que puede llegar a ascender hasta el 30%.

DIAGNÓSTICO

Para el diagnóstico, hay que tener en mente la **tríada de Charcot**, consistente en dolor abdominal en hipocondrio derecho o epigastrio, fiebre (generalmente asociada a tiritona) e ictericia. En el caso de mayor gravedad (generalmente en mayores de 70 años), pueden añadirse confusión mental y shock, formando así la **pentada de Reynolds**.

Sin embargo, la triada completa aparece en menos de la mitad de los pacientes, por lo que se requiere alto índice de sospecha (especialmente en diabéticos, ancianos, inmunodeprimidos y pacientes en tratamiento con glucocorticoides). También pueden estar presentes complicaciones como abscesos hepáticos, sepsis, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, disfunción multiorgánica...

Habría que hacer diagnóstico diferencial con otros cuadros como la pancreatitis aguda, colecistitis, fuga biliar, abscesos hepáticos.

Los datos de laboratorio que se deben extraer desde el servicio de urgencias son:

- **Hemograma:** suele haber leucocitosis.
- **Bioquímica** con glucosa, urea, filtrado glomerular, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, GGT, LDH, PCR, PCT, bilirrubina total y fraccionada, fosfatasa alcalina (FA) si está disponible.
- **Coagulación básica.**
Suelen estar elevadas la bilirrubina (>2mg/dl) y las enzimas de colestasis (GGT, FA) en más del 90% de los pacientes, aunque también pueden aparecer elevadas las enzimas de citolisis debido al aumento de la permeabilidad hepatocitaria por la obstrucción biliar.
- **Hemocultivos x 2.** Es importante extraer hemocultivos antes de iniciar el tratamiento

antibiótico.

- **Ecografía abdominal.** La prueba de imagen de elección en el caso de sospecha es la ecografía abdominal.
- **TAC Abdominal.** Si se sospechan complicaciones, se puede solicitar un TC abdominal. No hay hallazgos patognomónicos que diagnostiquen colangitis, pero hay datos indirectos que pueden ayudar (dilatación de la vía biliar, visualizar la causa de obstrucción). La ecografía es más sensible para visualizar colelitiasis y dilatación de la vía biliar (el colédoco se considera dilatado cuando mide más de 6mm, o más de 8 mm en pacientes colecistectomizados). Sin embargo, el TC tiene mayor sensibilidad para detectar coledocolitiasis, la localización y la causa de la obstrucción.
- **Otras pruebas durante su ingreso:**
 - **Colangiorresonancia magnética.** Una vez ingresado, es posible que se soliciten otras pruebas de imagen como colangiorresonancia magnética.
 - **Ecoendoscopia o**
 - **CPRE.** Para filiar mejor la etiología y ayudar en el tratamiento.

Para evaluar la gravedad se utilizan las **Guías de Tokio de 2018**, que diferencian tres grados de colangitis:

- **Grado III (severa):** asociado a disfunción multiorgánica (cardiovascular, neurológica, respiratoria, renal, hepática y hematológica). Con la disfunción de un sólo aparato de los anteriores ya se considera severa.
- **Grado II (moderada):** dos de los siguientes (Leucopenia: $<4,000/\text{mm}^3$ o leucocitosis: $>12,000/\text{mm}^3$, $T^a > 39^\circ$, edad > 75 años, bilirrubina total $> 5 \text{ mg/dl}$, hipoalbuminemia).
- **Grado I:** No cumple criterios de grado II o III.

TRATAMIENTO

Las bases del tratamiento de la colangitis aguda son el drenaje biliar precoz y la antibioterapia:

- **Medidas de soporte:** sueroterapia, monitorización de constantes habituales (tensión arterial, frecuencia cardíaca y temperatura) y control del dolor.
- **Antibioterapia:** para la elección del antibiótico más adecuado, es necesario conocer las bacterias más habituales. Entre los Gram negativos, destacan por su frecuencia E. coli, Klebsiella, Enterobacter y P. Aeruginosa. El Gram positivo más frecuente es el Enterococo. En pacientes institucionalizados o con largas estancias hospitalarias habría que sospechar bacterias resistentes. Los anaerobios (Bacteroides, Clostridium) se presentan más habitualmente en colangitis graves y en ancianos con comorbilidades. Se suele iniciar el tratamiento con penicilinas asociadas a inhibidores de las betalactamasas o con cefalosporinas de 3ª o 4ª generación, y habría que mantenerlo durante 7-10 días.

GRADO I	• Cefalosporinas (cefotaxima, ceftriaxona) $\pm$ metronidazol • Ertapenem • Quinolonas: ciprofloxacino o levofloxacino $\pm$ metronidazol
GRADO II	• Piperacilina/tazobactam • Cefalosporinas (cefotaxima, ceftriaxona, cefepime, ceftazidima) $\pm$ metronidazol • Ertapenem • Quinolonas: ciprofloxacino o levofloxacino $\pm$ metronidazol

GRADO III

- Piperacilina/tazobactam
- Cefalosporinas (cefepime, ceftazidima) ± metronidazol
- Imipenem, meropenem, doripenem, ertapenem
- Aztreonam ± metronidazol

- **Drenaje biliar:** hay varias técnicas disponibles. La primera línea consiste en realizar CPRE. En las colangitis leves, se suele hacer en el caso de mala respuesta a las medidas anteriores. En las colangitis moderadas, no debería retrasarse más de 48 horas; en las graves, debería hacerse en las primeras 24 horas, aunque los tiempos dependen de la respuesta del paciente al tratamiento y a la disponibilidad del centro. Es una técnica limitada en pacientes con anastomosis en Y de Roux, Billroth II, intervención de Whipple.

Si la CPRE no es exitosa, puede hacerse drenaje transparietohepático (mayor tasa de complicaciones y morbilidad), drenaje guiado por ecoendoscopia o cirugía convencional. Tras la resolución del cuadro de colangitis de origen biliar se recomienda la colecistectomía.

BIBLIOGRAFÍA

- Montoro MA, García Pagán JC (Eds.) Gastroenterología y Hepatología. Problemas comunes en la práctica clínica. 2ª ed. Madrid: Jarpay Editores; 2012. p229-42.
- Ponce J, Castells Garangou A, Gomollón García F. Tratamiento de las enfermedades gastroenterológicas. 3ª ed. Barcelona: Elsevier Doyma; 2011.
- Takada, T. Tokyo Guidelines 2018: updated Tokyo Guidelines for the management of acute cholangitis/acute cholecystitis. J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2018;25(1):1-2.
- European Association for the Study of the Liver (EASL). Guías de práctica clínica de la EASL sobre la prevención, diagnóstico y tratamiento de la litiasis biliar. J Hepatol. 2016;65(1):146–181.